

Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares

Tema 13 · Integrado de Okeson (5.^a–6.^a ed.) · Historia, exploración y clasificación

El diagnóstico de TTM se construye con **historia clínica + exploración**. Los dos grandes grupos a diferenciar siempre son: **trastornos de los músculos masticatorios y trastornos intracapsulares (ATM)**.

1. Diagnóstico diferencial: músculo vs ATM

Si el síntoma principal es dolor, hay que localizar el origen. La provocación local debe acentuarse. Usa estos siete ejes (Okeson):

Criterio	Más sugestivo de ATM	Más sugestivo de músculo
Historia / inicio	Síntomas constantes o empeoran desde un hecho desencadenante (trauma, apertura forzada)	Ciclos de intenso a leve; suelen relacionarse con estrés emocional o parafunción
Limitación de apertura	Típica 25–30 mm; end-feel duro (bloqueo discal). Excursión limitada al lado contralateral	Puede limitar en cualquier punto; end-feel blando . Excursiones poco limitadas
Desviación / deflexión	Desviación antes de ~30–35 mm sugiere alteración discal o incompatibilidad estructural	Desplazamientos amplios sin ruido articular (engramas musculares)
Maloclusión aguda	Pérdida de contacto posterior del lado afectado (presión sobre tejido retrodiscal)	Si pterigoideos: desoclusión posterior ipsilateral + contacto canino contralateral. Elevadores: “los dientes no ajustan”
Carga articular	Cargar la ATM aumenta el dolor intracapsular	La carga articular no reproduce el dolor muscular
Palpación	Dolor en polo lateral / región articular	Dolor en vientres musculares; puntos gatillo con referido en miofascial

Nota: si tras historia y exploración el origen sigue dudoso, Okeson contempla el bloqueo anestésico diagnóstico (p. ej. auriculotemporal) para ayudar a descartar componente intracapsular. Es una herramienta avanzada, no de rutina en el primer contacto.

2. Clasificación de los TTM (Okeson)

- Trastornos de los músculos masticatorios
- Trastornos de la ATM (disco, superficies, inflamación)
- Hipomovilidad mandibular crónica
- Trastornos del crecimiento

3. Trastornos musculares (secuencia clínica)

El signo más frecuente es el dolor muscular, agravado por función y por palpación. La limitación es extracapsular (inhibición por dolor).

Co-contracción protectora

Respuesta normal del SNC ante amenaza (dolor, cambio oclusal brusco, estrés). Aumenta la actividad del antagonista. Clínica: movimiento más lento y reducido, **sin dolor en reposo**, dolor con la función, sensación de debilidad/cansancio.

Dolor muscular local (mialgia no inflamatoria)

Primera respuesta del tejido ante co-contracción mantenida, uso excesivo o trauma. Clínica: similar a la co-contracción + **sensibilidad a la palpación** y debilidad real.

Dolor miofascial (mialgia por puntos gatillo)

Bandas tensas con **puntos gatillo** que, al palparse, reproducen dolor **referido** (puede imitar odontalgia). Distinto del dolor muscular local (dolor solo en el sitio).

Mioespasmo

Contracción involuntaria súbita y sostenida. Menos frecuente de lo que se cree en la práctica diaria.

Miositis / mialgia inflamatoria

Componente inflamatorio; dolor más continuo. Suele seguir a trauma o infección local.

4. Trastornos de la ATM

Alteraciones del complejo cóndilo-disco

- **Desplazamiento con reducción:** clic recíproco; apertura conservada; dolor variable.
- **Desplazamiento sin reducción (bloqueo cerrado):** apertura ~25–30 mm, deflexión al lado afectado, end-feel duro, desaparición del clic previo.
- Bloqueo intermitente: episodios de trabado que el paciente a veces “libera”.

Incompatibilidad estructural de superficies

Superficies que dejan de deslizarse con suavidad (macrotrauma frecuente). Incluye: alteraciones morfológicas, adherencias, subluxación y luxación espontánea.

Trastornos inflamatorios

- **Sinovitis / capsulitis:** dolor en área articular; palpación del polo lateral dolorosa; end-feel blando por dolor.
- **Retrodiscitis:** dolor constante articular; apretar aumenta el dolor; mordida separadora en el mismo lado no lo aumenta igual. Edema puede dar maloclusión aguda (desoclusión posterior ipsilateral).
- **Artritis:** osteoartritis / osteoartrosis / poliartritis; crepitación frecuente en cambios degenerativos.

5. Hipomovilidad crónica

- Anquilosis (fibrosa u ósea)
- Contractura muscular: **miostática** (acortamiento por no relajar) vs **miofibrosa** (adherencias hísticas)
- Choque coronoides

6. Secuencia práctica para mañana (en consulta / en clase)

1. Historia: inicio, constante vs cíclico, trauma, estrés, parafunción, tratamientos previos.
2. Apertura (dolorosa / no dolorosa), desviación, end-feel.
3. Palpación muscular (1–2 kg) y articular (polo lateral).
4. Ruidos: clic, crepitación; ¿desapareció un clic previo?
5. Clasificar: músculo vs ATM (y subtipo).
6. Tratamiento: **reversible primero** (educación, dieta, férula de estabilización, física). Irreversible solo con sistema estable e indicación clara.

Qué NO hacer: tallar oclusión de forma agresiva en dolor agudo; indicar reposicionamiento solo porque hay clic; confundir Clase de Angle con diagnóstico de TTM.

Referencias: Okeson JP. Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares. 5.ª y 6.ª ed. Caps. de historia, exploración, diagnóstico y clasificación de TTM. Complementa Temas 7–8 y Ficha de Diagnóstico TTM en Dentipedia.

Dr. Miguel Alvarado Avilés · Catedrático · Dentipedia